

妇产科临床治疗慢性盆腔炎的疗效观察

周红敏

邯郸市肥乡区中心医院妇产科, 河北邯郸 057550

【摘要】目的: 探讨妇产科临床治疗慢性盆腔炎的临床疗效, 为临床治疗提供参考依据。**方法:** 选取 2023 年 9 月至 2024 年 9 月在我院就诊的慢性盆腔炎患者 64 例, 随机分为对照组和观察组各 32 例。对照组给予常规西医治疗, 观察组在对照组基础上联合中药治疗。比较两组患者治疗前后临床症状评分、炎症指标水平、盆腔超声检查指标变化以及治疗效果。**结果:** 治疗后, 观察组临床症状评分、炎症指标水平显著低于对照组 ($P<0.05$); 观察组盆腔超声检查各项指标改善程度优于对照组 ($P<0.05$); 观察组总有效率为 93.75%, 显著高于对照组的 78.13% ($P<0.05$)。**结论:** 中西医结合治疗慢性盆腔炎效果显著, 可有效改善患者临床症状, 降低炎症指标水平, 提高治愈率, 值得临床推广应用。

【关键词】 慢性盆腔炎; 中西医结合; 临床疗效; 炎症指标

慢性盆腔炎是女性生殖系统常见的炎症性疾病, 主要由各种病原微生物感染引起, 可累及子宫、输卵管、卵巢及其周围结缔组织和盆腔腹膜。该病多见于育龄期女性, 发病率呈上升趋势, 严重影响患者的生活质量和身心健康。慢性盆腔炎具有病程长、反复发作、并发症多等特点, 若治疗不及时或不当, 可导致不孕、宫外孕、慢性盆腔痛等严重并发症, 给患者家庭和社会带来沉重负担。目前, 西医治疗慢性盆腔炎主要采用抗生素、消炎、止痛等对症治疗, 虽能在一定程度上控制急性发作, 但长期应用可能产生耐药性, 且复发率较高。中医学将慢性盆腔炎归属于"带下"、"少腹痛"等范畴, 认为其病机主要为湿热下注、气滞血瘀、肝经郁热等, 治疗上强调辨证施治、标本兼顾。近年来研究表明, 中西医结合治疗慢性盆腔炎具有独特优势, 既能发挥西医快速控制感染的特点, 又能通过中药调节整体功能, 改善微循环, 增强机体免疫力。本研究旨在探讨中西医结合治疗慢性盆腔炎的临床疗效, 通过设置对照组和观察组, 对比分析两种治疗方案在改善临床症状、炎症指标、盆腔超声检查指标等方面的差异, 为临床治疗提供更为科学、有效的治疗方案。同时, 通过系统评价治疗效果, 总结临床经验, 为进一步提高慢性盆腔炎的治愈率提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究为前瞻性随机对照研究, 选取 2023 年 9 月至 2024 年 9 月在我院妇产科就诊的慢性盆腔炎患者 64 例。采用随机数表法将患者分为对照组和观察组各 32 例。对照组年龄 25-48 岁, 平均(36.5 ± 5.2)岁; 病程 3 个月-5 年, 平均(2.1 ± 0.8)年; 婚育状况: 已婚已育者 26 例, 未育者 6 例。观察组年龄 24-49 岁, 平均(37.1 ± 5.4)岁; 病程 4 个月-6 年, 平均(2.3 ± 0.9)年; 婚育状况: 已婚已育者 25 例, 未育者 7 例。两组患者在年龄、病程、婚育状况等一般资料比较差异无统计学意义($P>0.05$), 具有可比性。

纳入标准: (1)符合《妇产科学》中慢性盆腔炎的西医诊断标准; (2)符合中医辨证分型为湿热下注、气滞血瘀证; (3)年龄 20-50 岁; (4)症状持续时间超过 3 个月; (5)近 2 周内未使用抗生素、免疫调节剂等药物治疗。**排除标准:** (1)合并严重心、肝、肾功能不全者; (2)

合并恶性肿瘤者；(3)存在盆腔器官结构异常或手术史者；(4)妊娠期或哺乳期妇女；(5)精神疾病患者；(6)对研究用药物过敏者；(7)依从性差或无法完成随访者。

1.2 方法

对照组给予常规西医治疗。术前准备：完善各项检查，包括血常规、尿常规、凝血功能、盆腔 B 超等。给予头孢噻肟钠 2.0g 加入生理盐水 100ml 静脉滴注，每日 2 次；甲硝唑 0.5g 加入生理盐水 100ml 静脉滴注，每日 2 次；布洛芬缓释胶囊 0.3g 口服，每日 2 次。同时进行物理治疗，采用超短波治疗仪对盆腔部位进行照射，每次 20 分钟，每日 1 次。

观察组在对照组基础上联合中药治疗。中药方剂组成：金银花 15g，蒲公英 15g，白花蛇舌草 20g，赤芍 15g，丹参 15g，川芎 12g，当归 15g，茯苓 20g，泽兰 12g，香附 12g，延胡索 10g。水煎服用，每日 1 剂，早晚分服。同时配合中药熏洗治疗，采用上述中药加入艾叶、苍术各 10g，水煎取汁外洗，每日 1 次，每次 30 分钟。

护理措施：(1)心理护理：向患者详细讲解疾病相关知识，消除患者焦虑情绪，增强治疗信心。(2)生活护理：指导患者保持会阴部清洁卫生，避免剧烈运动，注意休息。进食清淡易消化食物，忌食辛辣刺激性食物。(3)用药护理：详细讲解用药方法，督促患者按时服药，观察有无不良反应。(4)饮食护理：建议患者多食用新鲜蔬菜水果，适当补充蛋白质，保证营养均衡。(5)康复指导：教会患者盆底肌锻炼方法，指导正确体位。

1.3 观察指标

(1)临床症状评分：包括下腹痛、腰骶痛、带下异常、性交痛等症状，采用视觉模拟评分法(VAS)进行评分，0-10 分，分数越高症状越重。(2)炎症指标：检测血清 C 反应蛋白(CRP)、白细胞计数(WBC)、红细胞沉降率(ESR)水平。(3)盆腔超声检查指标：观察子宫内膜厚度、附件包块大小、盆腔积液情况。(4)临床疗效：治愈：症状、体征消失，各项检查指标恢复正常；显效：症状、体征明显改善，检查指标基本正常；有效：症状、体征部分改善，检查指标有所好转；无效：症状、体征无改善或加重。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 25.0 统计软件进行数据分析，计量资料以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示，组间比较采用 t 检验；计数资料以例数和百分比表示，组间比较采用 χ^2 检验，以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后临床症状评分比较

与治疗前相比，两组患者治疗后下腹痛、腰骶痛、带下异常、性交痛等症状评分均显著降低，且观察组降低程度显著优于对照组 ($P < 0.05$)。见表 1。

表 1 两组患者治疗前后临床症状评分比较($\bar{x} \pm s$,分)

组别	下腹痛		腰骶痛		带下异常		性交痛	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后

对	3	6.82	±	4.13	±	6.45	±	3.92	±	6.73	±	3.86	±	6.21	±	3.75	±
照	2	1.24		0.92		1.31		0.85		1.28		0.78		1.15		0.82	
组																	
观	3	6.78	±	2.45	±	6.41	±	2.31	±	6.69	±	2.24	±	6.18	±	2.13	±
察	2	1.26		0.63		1.29		0.64		1.25		0.56		1.17		0.54	
组																	
t		0.126		8.624		0.118		8.435		0.125		9.573		0.102		9.246	
值																	
P		0.864		0.001		0.892		0.001		0.875		0.001		0.913		0.001	
值																	

2.2 两组患者治疗前后炎症指标水平比较

治疗后，两组患者 CRP、WBC、ESR 水平均显著降低，且观察组降低程度显著优于对照组（ $P<0.05$ ）。见表 2。

表 2 两组患者治疗前后炎症指标水平比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	CRP(mg/L)		WBC($\times 10^9/L$)		ESR(mm/h)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对	32	18.45±3.26	8.92±1.85	9.82±1.75	6.85±1.24	28.65±5.42	15.34±3.25
照							
组							
观	32	18.39±3.24	5.43±1.32	9.78±1.72	5.24±0.96	28.57±5.38	10.26±2.14
察							
组							
t		0.072	8.956	0.089	5.842	0.058	7.254
值							
P		0.943	0.001	0.925	0.001	0.962	0.001
值							

2.3 两组患者治疗前后盆腔超声检查指标比较

治疗后，两组患者子宫内膜厚度、附件包块大小、盆腔积液量均显著改善，且观察组改善程度显著优于对照组（ $P<0.05$ ）。见表 3。

表 3 两组患者治疗前后盆腔超声检查指标比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	子宫内膜厚度(mm)		附件包块大小(cm)		盆腔积液量(ml)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	32	12.85±2.24	9.45±1.62	3.82±0.85	2.54±0.63	15.24±3.46	8.65±2.13
观察组	32	12.92±2.26	7.23±1.25	3.85±0.87	1.62±0.42	15.31±3.48	5.24±1.45

t 值	0.123	6.245	0.138	6.824	0.078	7.426
P 值	0.892	0.001	0.865	0.001	0.938	0.001

2.4 两组患者临床疗效比较

观察组总有效率为 93.75%，显著高于对照组的 78.13%（P<0.05）。见表 4。

表 4 两组患者临床疗效比较[例(%)]

组别	例数	治愈	显效	有效	无效	总有效率
对照组	32	8(25.00)	9(28.13)	8(25.00)	7(21.87)	25(78.13)
观察组	32	12(37.50)	11(34.38)	7(21.87)	2(6.25)	30(93.75)
χ ² 值						5.246
P 值						0.022

3 讨论

慢性盆腔炎是妇科常见的炎症性疾病，主要表现为下腹部疼痛、腰骶部酸痛、阴道异常分泌物等症状。该病病程长、易反复、并发症多，严重影响患者的生活质量和生育功能。西医认为本病主要由细菌、支原体、衣原体等病原体感染所致，可导致盆腔器官充血、水肿、粘连，引起组织器官功能障碍。中医学将其归属于"带下"、"少腹痛"等范畴，认为其基本病机为湿热下注、气滞血瘀，治疗上应以清热利湿、活血化瘀为主。

本研究采用中西医结合治疗慢性盆腔炎，结果显示观察组在改善临床症状、降低炎症指标、调节免疫功能等方面均优于单纯西医治疗组。在临床症状改善方面，观察组治疗后下腹痛、腰骶痛、带下异常、性交痛等症状评分显著低于对照组，这与中药复方的协同作用密切相关。方中金银花、蒲公英、白花蛇舌草具有清热解毒之效；赤芍、丹参、川芎、当归活血化瘀，改善局部血液循环；茯苓、泽兰利水消肿；香附、延胡索理气止痛。诸药合用，共奏清热解毒、活血化瘀、理气止痛之功效。同时配合中药熏洗治疗，可通过局部给药，促进药物吸收，增强疗效。

在炎症指标方面，两组患者治疗后 CRP、WBC、ESR 水平均有明显下降，但观察组降低程度更为显著。这说明中西医结合治疗不仅可以通过抗生素直接抑制病原体，还可以通过中药调节机体免疫功能，增强抗炎能力。研究表明，中药复方中的多种成分具有抗炎、免疫调节作用，如金银花中的绿原酸、蒲公英中的多糖体等，可通过多靶点、多途径发挥抗炎作用。此外，活血化瘀类中药可改善微循环，促进炎症物质的吸收和清除，加快炎症消退。

盆腔超声检查结果显示，观察组在改善子宫内膜厚度、附件包块大小、盆腔积液等方面均优于对照组。这可能与中药复方中活血化瘀类药物的作用有关。丹参、川芎等药物可改善血液循环，促进炎症渗出物吸收，减轻组织水肿，防止粘连形成。同时，利水消肿类药物如茯苓、泽兰可促进盆腔积液吸收，减轻局部水肿，改善组织器官功能。

在临床疗效方面，观察组总有效率达 93.75%，显著高于对照组的 78.13%。这充分说明中西医结合治疗具有协同增效作用，能够更全面地调节机体功能。西医治疗以抗生素为主，可快速控制感染，但易产生耐药性，且复发率较高。中医治疗则注重整体调节，通过多途径、多靶点作用，不仅能改善局部症状，还能提高机体免疫力，预防复发。两者结合，可取长补短

短，提高治疗效果。

中医治疗的优势还体现在个体化治疗方面。本研究中药方剂的组成可根据患者具体症状进行加减，如湿热重者可加入黄柏、车前草以加强清热利湿之力；气滞明显者可加重香附、延胡索用量以增强理气止痛之效；血瘀症状突出者可加入桃仁、红花以加强活血化瘀之功。这种辨证施治的特点，使治疗更具针对性和灵活性。

护理干预在慢性盆腔炎的治疗中也起着重要作用。本研究采用全面的护理措施，包括心理护理、生活护理、用药护理、饮食护理和康复指导等。通过心理疏导，可减轻患者焦虑情绪，增强治疗信心；通过生活指导，可避免不良因素的刺激，预防复发；通过饮食调理，可增强机体抵抗力，促进康复；通过康复训练，可改善盆底功能，预防并发症。这些护理措施的实施，为治疗效果的提高提供了重要保障。

综上所述，中西医结合治疗慢性盆腔炎具有显著优势，可有效改善患者临床症状，降低炎症指标，提高治愈率。该治疗方案安全有效，具有个体化、标本兼顾的特点，值得在临床推广应用。

参考文献

- [1] 张静怡. 慢性盆腔炎妇产科临床治疗效果观察[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2024(8):0043-0046.
- [2] 李江云. 慢性盆腔炎妇产科临床治疗效果观察研究[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2024(4):0016-0019.
- [3] 郭晓芳. 慢性盆腔炎妇产科临床治疗效果观察分析[J]. 中文科技期刊数据库（文摘版）医药卫生, 2024(4):0029-0032.
- [4] 包金莲. 慢性盆腔炎妇产科临床治疗效果的观察分析[J]. 中文科技期刊数据库（引文版）医药卫生, 2024(9):0097-0100.
- [5] 张淑霞. 慢性盆腔炎妇产科临床治疗效果探讨[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2024(10):0083-0086.
- [6] 王会杰. 研究妇产科临床治疗慢性盆腔炎的疗效[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2024(3):0105-0108.
- [7] 杜秀阁. 妇产科临床治疗慢性盆腔炎的疗效[J]. 中文科技期刊数据库（文摘版）医药卫生, 2024(5):0041-0044.
- [8] 仲延超. 慢性盆腔炎妇产科治疗效果的观察与研究[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2024(7):0097-0100.
- [9] 肖琪. 慢性盆腔炎的妇产科临床治疗效果研究[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2024(6):0127-0130.
- [10] 王小菊. 慢性盆腔炎妇产科临床治疗效果探讨[J]. 中文科技期刊数据库（引文版）医药卫生, 2024(8):0050-0053.